

联合使用抗生素应注意药物相互作用

田广红 梁学光 (广州市皮肤病防治所 广州 510095)

关键词: 抗生素; 联合用药
中图分类号: R952 文献标识码: A 文章编号: 1007-9939(2002)05-0044-02

药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理功能并规定有适应症、用法、用量的物质。合理配方可降低不良反应,同时可提高治疗效果,而不合理配方可降低疗效,甚至疗效完全抵消。为了在安全、有效、合理、经济用药的大前提下,本文着重提出,在临床用药中,特别是在抗生素联合用药方面,要注意药物相互作用。最近随意抽查统计了 2000 年 3 月~2001 年 2 月不同月份各 1~2 日处方 2 436 张中,出现使用抗生素处方有 1 007 张,占总处方数的 41.3%;使用 3 种以上抗生素处方 118 张,占使用抗生素处方的 11.71%,可见使用抗生素的处方所占的比重较大。另外,一些明显的药物不良相互作用,在处方中仍有出现,应引起重视。

1 处方实例

1.1 处方 1

苄星青霉素针	120 万 u×16 支
利多卡因针	2ml×32 支
甲砒霉素胶囊	0.25×60 粒
盐酸多西环素胶囊	0.1×48 粒

分析:该处方是治疗性病用药,其中苄星青霉素与甲砒霉素(氯霉素类)同时使用不合理。苄星青霉素与盐酸多西环素(四环素类)同时使用也不合理。由于青霉素类药物是细菌繁殖期的杀菌剂,而氯霉素类和四环素类药物都是抑菌剂,可干扰影响青霉素的杀菌活性,两者不宜同时使用;^[1、2]若临床上必须并用,建议先用青霉素 2~3h 后,再用氯霉素或四环素类。

1.2 处方 2

安体舒通片	20mg×21 片
维生素 B ₆ 片	10mg×21 片
葡萄糖酸锌片	70mg×21 片
盐酸多西环素缓释胶囊	0.1g×7 粒
异维 A 酸胶丸	10mg×20 粒
0.3%维胺酯乳膏	25g×1 支

分析:本处方主要是治疗痤疮用药。其中盐酸多西环素与葡萄糖酸锌同用不合理。四环素类药与

葡萄糖酸锌中的金属锌 2 价离子可形成不溶性络合物,使两者药物在体内吸收减少致两药的疗效都降低。^[3、4]此外,本方的异维 A 酸类药(包括内服与外用)与四环素类药同用也不合理。两者合用,易引起颅内压升高,可导致“脑假瘤”及产生视网膜出血。^[3、4]

1.3 处方 3

盐酸大观霉素针	2g×2 支
头孢哌酮钠 0.5g	
舒巴坦钠针 0.5g	1g×4 支
利多卡因针	2ml×4 支
克拉维酸钾 125mg	
羟氨苄青霉素 250mg	375mg×21 片
头孢克肟胶囊	100mg×14 粒
培氟沙星片	0.2×28 片
维生素 B _{co} 片	21 片

分析:本方是治疗性病用药,其中盐酸大观霉素与舒巴坦钠合用不合理。大观霉素属氨基糖甙类药和舒巴坦钠(称青霉素烷砒钠),两者同时使用有毒副作用,因为,氨基糖甙类和舒巴坦,在体内主要经肾排泄,尿中均有很高的药物浓度。因此,肾毒性也增强,有可能引起急性肾功能不全,故不宜联用。若必须联合用药,两者剂量应减少,并定期监测检查肾功能及血药浓度,^[3]这两项,对于门诊病人没做到。本方也未因此两药联用而减少用量。另外,本方联用几种抗生素,如此多种药的大包围治疗,应引起注意。

1.4 处方 4

阿奇霉素针	250mg×14 支
5%葡萄糖注射液	250ml×7 瓶
甲砒霉素胶囊	250 mg×90 粒
清浊去毒丸	8g×9 包×5 盒
氧氟沙星胶囊	0.1 g×60 粒

分析:本处方是治疗性病用药。其中甲砒霉素胶囊是氯霉素类,阿奇霉素针是大环内酯类,氯霉素与大环内酯类抗生素有拮抗作用,合用无益,^[2]其中甲砒霉素(氯霉素类)与氧氟沙星胶囊(喹诺酮类)合用也不合理,因为氯霉素可使喹诺酮类药物作用

降低,使诺氟沙星作用完全消失,使氧氟沙星作用部分消失。^[2]

2 体会和建议

2.1 重视药物相互作用的不良反应,加强做好药物不良反应的监测。由于药物在体内的相互作用是隐蔽的,其不良反应可给病人身体带来危害和引起药源性疾病。况且有些毒副作用是迟发性的,要滞迟一段时间才出现,而成为难明原因的症状。因此,这必须引起关注,做好药物不良反应的监测工作是当务之急。

2.2 加强医德管理,合理用药,提高药物治疗水平。药物是治疗疾病的特殊物质,只有医德高尚、医术高超的医师才能给予病人明确的诊断,对症下药方能取得良好的治疗效果。药物相互作用是药物不良反应的重要因素,用药种类越多,不良反应发生率也越高。在抗生素用药方面,也是如此。我们主张,坚持能用 1 种或 2 种抗生素治疗疾病的,决不用 2 种以上抗生素。

•药物经济学•

老年高血压 4 种治疗方案的成本-效果分析

林 彤 黄乐珊 司徒冰 梁智江(广州医学院附属广州市第二人民医院药剂科 广州 510150)

摘要:**目的** 评价采用 4 种方案治疗老年高血压患者的药物经济学效果。**方法** 调查我院 1999 年 6 月~2001 年 5 月住院病例中入选老年高血压患者病例共 124 例。采用单用钙拮抗剂(CCB)、CCB+血管转换酶抑制剂(ACEI)、CCB+利尿剂和 CCB+β-受体阻滞剂 4 种治疗方案,运用药物成本-效果分析的方法进行评价。**结果** 采用单用钙拮抗剂的成本效果比最低。依次分别是 CCB+利尿剂 > CCB+ACEI > CCB+β-受体阻滞剂。**结论** 老年高血压患者不仅用钙拮抗剂是较安全有效的,而且从药物经济学的角度来考虑也是较合理的。

关键词:高血压;药物经济学

中图分类号:F407.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1007-9939(2002)05-0045-02

高血压为常见的心血管疾病,是老年人常见的心血管病。根据中华医学会老年医学会提出的大于 60 岁为老年人^[1],近年来由于人口老化的进程加速,至 2000 年我国 60 岁以上老人约占人口的 10%,进入标准型老年结构。国内对 95 万人调查证明,老年收缩期高血压(ISH)是心血管独立的危险因素,收缩压(SBP)每升高 0.13kPa(1mmHg),每年病死率升高 1%。因此,近年来国内外对老年高血压的研究逐步深入。本文对目前临床上老年高血压患者常用的 4 种治疗方案进行成本效果分析,寻找“最理想”的用药方案,为临床合理用药,节约有限的医疗费用提供参考。

中国知网 <https://www.cnki.net>

2.3 加强对药物尤其是新药的宣传推介和监管。当前,大量高效、选择性强和治疗剂量范围狭窄的药物不断上市,增加了联合用药的机会,因而药物不良反应的发生率和严重反应也日益突出。因此,在临床选择用药工作中,医师和药师们都非常渴望正当的推介新药。但是,目前大部分的药品使用说明书中都不十分重视药物联用的相互作用和不良反应、毒副作用等内容。建议,药品监管部门加大力度对药品使用说明书的审查监管。

参考文献

- 1 临床合理用药指南·北京:人民卫生出版社,2000:10
- 2 药师手册·北京:人民卫生出版社,2001:358~359
- 3 药物临床应用撷萃·北京:八一出版社,1994:832~833, 871~872. 870~871.844~853
- 4 药物不良相互作用的临床意义与处理·北京:中国科学技术出版社,1993:673,650~731

(收稿:2002-07-20;修回:2002-08-10)

1 资料和方法

1.1 病例选择 根据中国高血压防治指南的诊断标准^[1],即未接受抗高血压药物时收缩压≥140mmHg (18.7kPa)和舒张压≥90mmHg (12kPa)。查阅我院 1999 年 6 月~2001 年 5 月住院病例,选择老年高血压患者 286 例,剔除其它治疗方案和围手术病例,入选病例共 124 例。

1.2 给药方案 我们根据中国高血压防治指南所建议的五大类一线用药,选择了 4 种临床上较多运用的治疗方案分别为 A、B、C、D 组。

A 组[单用钙拮抗剂(CCB)]:硝苯地平缓释剂

B 组:[CCB+血管转换酶抑制剂(ACEI)]:硝苯地平缓释剂+卡托普利

C 组:[CCB+利尿剂]:硝苯地平缓释剂+呋